



**Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú, Decana de América
Facultad de Medicina
Escuela Profesional de Obstetricia**

Contraindicaciones médicas en mujeres usuarias de métodos
anticonceptivos hormonales atendidas en el Centro de Salud 10 de
octubre, 2023

PROYECTO DE TESIS

Para optar el Título Profesional de Licenciado en Obstetricia

AUTORA

GESTRO ANTÓN, Ana Maria Jesús

ASESORA

Dra. SALAZAR SALVATIERRA, Emma Felicia

Lima, Perú

2024

ÍNDICE

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	3
1.1.	3
1.2.	5
1.3.	5
1.4.	6
1.5.	7
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	4
2.1.	8
2.1.1.8	
2.1.2.12	
2.1.3.21	
2.2.	21
CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS	5
3.1.	22
3.1.1.22	
3.1.2.22	
3.2.	22
3.3.	22
3.4.	23
3.5.	23
3.6.	28
3.7.	28
3.8.	28
3.9.	29
3.10.	29
CAPÍTULO IV: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	7
3.1.	30
3.2.	¡Error! Marcador no definido.
3.3.	32
Referencias bibliográficas	8
Anexos	9

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la planificación familiar se define como la estrategia que permite a las personas decidir cuántos hijos tener y a su vez determinar los intervalos entre estos embarazos; por consiguiente, esto se consigue a través del uso de métodos anticonceptivos y tratamientos de la infertilidad. (1) . Por otro lado, se debe resaltar el papel importante que cumple la consejería en la planificación familiar; cuyo rol es orientar a la mujer y su pareja en la elección del método anticonceptivo que mejor se adapte a ellos y a brindarle el apoyo que necesiten ante cualquier problemática que pueda surgir con el método anticonceptivo seleccionado. (2) Asimismo, existen diversos tipos de métodos anticonceptivos entre ellos se encuentran los métodos anticonceptivos hormonales; tales como: anticonceptivos orales combinados, anticonceptivos orales de progestágeno solo, inyectable mensual, inyectable de progestágeno solo, parche anticonceptivo combinado, anillo vaginal anticonceptivo combinado, anillo vaginal liberador de progesterona, implantes anticonceptivos y dispositivos intrauterinos de levonogestrel. (3)

No obstante, con la finalidad de determinar la seguridad de estos métodos anticonceptivos ante las diversas condiciones o características médicas relevantes que presentan algunas mujeres, se elaboraron recomendaciones para ayudar a los proveedores de Salud Sexual, denominados Criterios Médicos de Elegibilidad para el Uso de Métodos Anticonceptivos. Así pues, dichos criterios médicos basados en la evidencia científica forman la base para definir las contraindicaciones de cualquier método anticonceptivo. Determinando que, para cada condición médica, se clasifique cada método anticonceptivo en cuatro categorías; siendo la categoría 1 y 2 donde ninguno de los métodos se encuentra contraindicado y las categorías 3 y 4 en donde existen las contraindicaciones para su uso. (4)

A nivel mundial, según la OMS se estima que un 77% de mujeres en edad reproductiva satisfacen sus necesidades de Planificación Familiar usando métodos anticonceptivos modernos (hormonales). (5) Un estudio, en Alemania, determinó que el uso de anticonceptivos hormonales combinados, están contraindicados para ciertos factores de riesgo; tales como, tromboembolismo, diabetes mellitus, mujeres mayores de 35 años, abuso de nicotina, hipertensión arterial, tumores hepáticos, migraña, y epilepsia. Por lo tanto, consideraron necesario realizar un examen clínico meticuloso como parte de la consejería anticonceptiva. (6) Asimismo, en EE. UU, otro estudio también determinó algunas consideraciones sobre la anticoncepción hormonal combinada, debido a que, las hormonas presentes en dicho método anticonceptivo tienden a aumentar el riesgo de eventos de tromboembolismo venoso en mujeres de edad reproductiva. Por lo cual, también consideraron necesario que el personal debe orientar a la mujer sobre los signos y síntomas de trombosis arterial y venosa, con la finalidad de elegir un método anticonceptivo seguro para ellas. (7)

En otra región del mundo, como en Latinoamérica, la prevalencia más baja en el uso de anticonceptivos modernos (hormonales) lo ocupó Haití con un 31.3%, seguido de Bolivia con un 34,6%, mientras que Brasil, Colombia, Cuba, Costa Rica y Paraguay reportan una prevalencia del 70%. (8)

Específicamente, en Cuba, otro estudio determinó la importancia de identificar cada factor de riesgo para poder elegir el método anticonceptivo más adecuado, al igual que, ofrecer vigilancia para detectar precozmente las complicaciones; también, recomienda que en aquellas mujeres que presenten ciertos antecedentes de tromboembolismo venoso, lo más recomendable es el uso de progestágenos; ya que, estos han demostrado tener un riesgo muy bajo. (9)

Por otro lado, en Perú, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), en el año 2021, se determinó que solo el 57% de las mujeres convivientes o casadas, utilizaban algún tipo de método anticonceptivo moderno; sin embargo, dicho porcentaje estuvo muy por debajo de América

Latina y el que existe en los países vecinos; lo cual, ratifica que hace falta mayor énfasis en el abordaje de la planificación familiar y asesoría anticonceptiva. (10) El abordaje de este estudio tomó en cuenta el Centro de Salud “10 de Octubre”, el cual es un establecimiento de categoría I3 , y se encuentra localizado en el distrito de San Juan de Lurigancho, dicho Centro de Salud consta de tres consultorios de Obstetricia; además, cuenta con la participación de cuatro obstetras, las cuales llevan a cabo actividades preventivas promocionales; en especial, la consejería en Planificación Familiar, brindándole a las mujeres que acuden, la posibilidad de elegir un método anticonceptivo de acuerdo a su elección y posterior evaluación; a través, de un examen clínico y físico.

1.2. Formulación del problema

¿Cuáles son las contraindicaciones médicas más frecuentes que presentan las mujeres usuarias de métodos anticonceptivos hormonales en el Centro de Salud 10 de octubre, 2023?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Determinar las contraindicaciones médicas más frecuentes que presentan las mujeres usuarias de métodos anticonceptivos hormonales en el Centro de Salud 10 de octubre, 2023.

1.3.2. Objetivos específicos

Describir las contraindicaciones médicas más frecuentes que presentan las mujeres usuarias de métodos anticonceptivos hormonales sólo de progestágenos.

Identificar las contraindicaciones médicas más frecuentes que presentan las mujeres usuarias de métodos anticonceptivos hormonales combinados.

1.4. Justificación

Existen condiciones médicas que ponen en riesgo la vida de las mujeres cuándo utilizan ciertos métodos anticonceptivos hormonales; debido a que, algunos de ellos presentan contraindicaciones en su uso; por ello, la importancia de realizar un abordaje integral a la mujer cuando esta acude por asesoría anticonceptiva.

Por consiguiente, el presente estudio no solo permitirá ayudar a comprender el problema, sino también que podría servir como pilar para que se puedan diseñar mejoras en las estrategias de abordaje dentro de la Planificación Familiar, ayudando así, a maximizar los beneficios ofrecidos a las usuarias que por su condición médica se perciben limitadas para gozar del derecho a usar anticonceptivos hormonales.

Asimismo, este estudio buscará contribuir con el profesional Obstetra; ofreciéndole un nuevo instrumento que pueda permitirle detectar con mayor premura si existen contraindicaciones médicas en las usuarias que acudan a sus consultorios por asesoría anticonceptiva; ya que, el instrumento realizado en el presente estudio está creado en base a guías y normas que cuentan con vigencia y credibilidad en el campo de la Obstetricia a nivel mundial y nacional.

Por último, este estudio sería un incentivo para continuar sobresaliendo en la calidad brindada durante las atenciones que realiza el profesional Obstetra, gracias a que este realiza una correcta anamnesis con mayor énfasis en la consulta de antecedentes o condiciones médicas que presente la usuaria, con el fin de determinar que método anticonceptivo es aplicable para su caso, contribuyendo a que cada mujer cuente con la información necesaria lo cual le permitirá realizar una correcta toma de decisiones al momento de elegir el método que va a utilizar a lo largo de toda su vida.

1.5. Limitaciones

El estudio presenta las siguientes limitaciones; ya que, al ser un estudio con un muestreo no aleatorio o no probabilístico, no se podrá extrapolar los resultados; ni se podrá demostrar causalidad debido a que el estudio es de tipo descriptivo. Asimismo, al tener ser un estudio cuya recolección de datos se lleve acabo mediante la observación de historias clínicas, puede que la información no sea la correcta.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Marco teórico

2.1.1. Antecedentes

Assiri G., Bannan D., Alshehri G., Alshyhaní M., Almatri W., Mahmoud M., en Arabia Saudita, en el año 2022, desarrollaron el estudio “The Contraindications to Combined Oral Contraceptives among Reproductive-Aged Women in an Obstetrics and Gynaecology Clinic: A Single-Centre Cross-Sectional Study” que tuvo como objetivo determinar la proporción estimada de contraindicaciones entre las mujeres que toman anticonceptivos orales combinados y evaluar los factores asociados con sus contraindicaciones. Fue de tipo de diseño transversal retrospectivo considerando una muestra de 380 mujeres en edad reproductiva de una Clínica de Obstetricia y Ginecología, entre las edades de 18 a 49 años, los datos se extrajeron de las historias clínicas electrónicas y también se utilizó una encuesta estandarizada. Se encontró que al menos 119 mujeres presentaban al menos una contraindicación 3 y 4 según los Criterios Médicos de Elegibilidad de la OMS, de estas el 23, 7% presentó una contraindicación, 4,5% tenían dos contraindicaciones, 1,8% tenía tres contraindicaciones y 0.8% cuatro contraindicaciones. Las contraindicaciones más comunes observadas para la categoría 3 fueron: hipertensión controlada (12,1%), lactancia materna desde las 6 semanas hasta menos de 6 meses después del parto (4,0%). Las contraindicaciones más comunes observadas para la categoría 4 fueron: cirugía mayor con inmovilización prolongada (4,7%), migraña con aura a cualquier edad (4,2%) y diabetes mellitus con complicaciones (3,2%). Se concluyó que la proporción estimada de contraindicaciones a los anticonceptivos orales combinados fue de 31 ,3% por lo cual los autores recomiendan evaluar los riesgos frente a los beneficios para garantizar un uso seguro de los anticonceptivos orales combinados. (11)

Dutton C., Kim R., Janiak E., en EE.UU, en el año 2021, realizaron un estudio denominado “Prevalence of contraindications to progestin-only contraceptive pills in a multi-institution patient database” que tuvo como objetivo calcular la

prevalencia de contraindicaciones para las píldoras de progestágenos solo, entre mujeres en edad reproductiva para evaluar la seguridad de la administración. Fue un tipo de diseño descriptivo transversal, considerando una muestra a las mujeres de 10 a 45 años de una base de datos de múltiples instituciones de EE.UU. Se encontró que la contraindicación con mayor prevalencia fue el cáncer de mama y este figuraba como diagnóstico en ambos grupos de mujeres que fueron evaluadas. Se concluyó que la prevalencia de las contraindicaciones a los anticonceptivos orales de progestágenos en mujeres en edad reproductiva es baja. (12)

Judge C., Zhao X., Sileanu F., Mor M., Borrero S., en EE.UU , en el año 2017, elaboraron un estudio denominado “Medical contraindications to estrogen and contraceptive use among women Veterans” que tuvo como objetivo estimar la prevalencia de contraindicaciones médicas para la anticoncepción hormonal combinada que contiene estrógenos entre mujeres veteranas en edad reproductiva y evaluar la relación entre las contraindicaciones y el uso de anticonceptivos. Fue un tipo de diseño transversal considerando una muestra de 2302 mujeres de 18 a 45 años que utilizan el Sistema de Atención Médica de la Administración de Veteranos para su atención primaria. Se utilizó la encuesta. Se encontró que, dentro de las 1169 mujeres en riesgo de un embarazo no deseado, el 29% tenían al menos una contraindicación para la anticoncepción hormonal combinada y las contraindicaciones más prevalentes fueron la hipertensión arterial (14,9%), migraña (8,7%). Se llegó a la conclusión de que las mujeres veteranas del estudio tuvieron una gran carga de contraindicaciones médicas para el estrógeno y estas tenían menos probabilidades de poder usarlos, lo que pone en descubierto una necesidad insatisfecha de anticoncepción en esa población vulnerable. (13)

Lauring J., Lehman E., Deimling T., Legro R., Chuang C., en EE.UU, en el año 2016, desarrollaron el estudio denominado “Combined hormonal contraception use in reproductive age women with contraindications to estrogen use” que tuvo como objetivo describir la prevalencia del uso de anticonceptivos hormonales combinados entre una muestra de mujeres en edad reproductiva con contraindicaciones médicas para el uso de estrógenos. Fue de tipo de diseño

longitudinal considerando una muestra de 987 mujeres miembros de Highmark Health en Pensilvania entre las edades de 18 a 40 años, se utilizó una encuesta. Se encontró que el 13% de la muestra poseía una contraindicación médica para el uso de anticonceptivos con estrógenos, de las cuales la migraña con aura fue la contraindicación más común (81%), seguida por las fumadoras mayores de 35 años (7%), hipertensión arterial (11%), antecedentes de tromboembolismo venoso (4%), y diabetes con complicaciones (2%). Se demostró que hubo una alta tasa de uso de anticonceptivos hormonales combinados en las mujeres que poseían alguna contraindicación médica para el uso de estrógenos. (14)

Silva D., Felisbino – Mendes M., Santos M., Carvalho D., Velasquez – Melendez G., en Brasil, en el año 2016, elaboraron el estudio denominado “Factors associated with the contraindicated use of oral contraceptives in Brazil” que tuvo como principal objetivo estimar la prevalencia del uso contraindicado de anticonceptivos orales y los factores asociados en mujeres brasileñas. Fue de tipo de diseño longitudinal cuya muestra fue de 20, 454 mujeres en edad reproductiva de 15 a 49 años a las cuáles se les entrevistó aplicando un cuestionario. Se encontró que de la población total el 21% presentó alguna contraindicación para el uso de anticonceptivos orales; asimismo, la contraindicación más frecuente en las usuarias fue la hipertensión arterial sistémica (15,1%) , la segunda contraindicación más frecuente fue el hábito de fumar en mujeres de 35 años a más (2,6%). Se demostró que los factores que permanecieron asociados a las contraindicaciones en mujeres usuarias de anticonceptivos orales fueron el bajo nivel educativo y la edad mayor o igual a 35 años. (15)

White K., Potter J., Hopkins K., Fernandez L., Amastae J., Grossman D., en EE.UU, en el año 2013, realizaron un estudio denominado “Contraindications to progestin-only oral contraceptive pills among reproductive aged women” que tuvo como objetivo determinar la prevalencia general de las contraindicaciones de las píldoras anticonceptivas orales de progestágeno en mujeres en edad reproductiva. Fue un tipo de diseño descriptivo transversal, considerando una muestra de 1257 mujeres en edad reproductiva de la población general en El

Paso, Texas que fueron parte de dos estudios diferentes. Se utilizó la lista de verificación. Se determinó que solo el 1.6% de las mujeres tenían al menos una contraindicación para los anticonceptivos orales de progestágenos, además el 0,6% de las mujeres del estudio prospectivo de usuarias del anticonceptivo oral combinado informaron tener alguna contraindicación para los anticonceptivos orales de progestágeno. Se demostró que la prevalencia de las contraindicaciones a los anticonceptivos orales de progestágenos fue muy baja en ambos estudios. (16)

Grosman D., Blanco K., Hopkins C., Amastae J., Shedlin M., Potter J., en EE.UU, en el año 2013, realizaron un estudio denominado “Contraindications to Combined Oral Contraceptives Among Over-the-Counter Compared With Prescription Users” que tuvo como objetivo comparar la proporción estimada de contraindicaciones a los anticonceptivos orales combinados entre mujeres que obtuvieron anticonceptivos orales combinados en clínicas públicas de EE.UU en comparación con mujeres que obtuvieron anticonceptivos orales combinados sin receta. Fue un tipo de diseño longitudinal, considerando una muestra de 501 mujeres que eran residentes del El Paso, Texas. Se utilizó la encuesta. Se determinó que la proporción estimada de cualquier contraindicación de categoría 3 (relativas) y 4 (absolutas) fue del 18%; además, la hipertensión arterial fue la contraindicación más prevalente, seguida por el tabaquismo a partir de los 35 años (4,9%) y la migraña con aura (4,1%) en las mujeres usuarias de los anticonceptivos hormonales orales combinados. Se demostró que las contraindicaciones relativas de anticonceptivos orales combinados son más comunes entre los usuarios que adquieren estos sin receta. (17)

2.1.2. Bases teóricas

Planificación Familiar y su importancia

El concepto esencialmente está ligado con el control de la natalidad; ya sea, en una comunidad, región o un país. Por lo cual, es necesario que la pareja se encuentre preparada de forma integral; es decir, económica, psicológica y socialmente para comenzar a procrear. Ósea, que debe disponer de los suficientes recursos para gozar de una vida digna y con oportunidades. (18)

Por ende, la importancia de la Planificación Familiar en la sociedad y en la salud sexual reproductiva, es para promover el bienestar y la autonomía de las mujeres, sus familias y comunidades; además, la calidad en la atención de la Planificación familiar es primordial para garantizar que se cumpla con altos estándares de salud para todas las personas. (19)

Salud Sexual y Reproductiva

La Salud Sexual y reproductiva; es un proceso permanente que busca conseguir un estado de bienestar físico, psicológico y cultural, que está meramente relacionado con el ejercicio de la sexualidad; como también, con las funciones relativas al sistema reproductor. Asimismo, también implica el disfrute de los derechos sexuales y reproductivos, la opción de procrear o no según los propios deseos, y el acceso a los servicios de salud como parte de la prevención y atención de cualquier alteración o enfermedad que afectan la esfera de la salud sexual y reproductiva. (20)

Embarazo no deseado

Los embarazos no deseados constituyen un gran problema de salud pública; porque, pueden generar una amplia gama de riesgos para la salud de la mujer y el niño; por ejemplo, malnutrición, maltrato, abandono e incluso la muerte. Asimismo, pueden reducir las posibilidades de educación y oportunidades laborales desencadenando pobreza y problemas que se extiendan generación tras generación. (21)

Métodos Anticonceptivos y tipos de métodos

Los métodos anticonceptivos ayudan a prevenir o evitar embarazos; e incluso alguno de ellos también sirven para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Existen diferentes formas de anticoncepción; ya que, depende de diversos factores: género, edad, si lo que está buscando un método para regularización hormonal, para evitar embarazo, enfermedades de transmisión sexual o ambas. Asimismo, existe otro factor como la durabilidad del método; es decir, un método que dure una sola relación coital o que sirva para años, o de manera permanente. En consecuencia, se clasifican en: métodos naturales, de barrera, hormonales, y definitivos o quirúrgicos. (22)

Anticonceptivos Hormonales

Los métodos anticonceptivos hormonales para el control de la natalidad usan hormonas para regular o detener la ovulación en la mujer y así evitar los embarazos. Las hormonas se pueden introducir de diferente forma en el cuerpo; es decir, a través de píldoras, inyecciones, parches cutáneos, anillos vaginales, sistemas intrauterinos, y varillas implantables. Asimismo, según los tipos de hormonas que se usan, estos pueden evitar la ovulación, espesar el moco cervical, ayudando a evitar que el espermatozoide llegue al óvulo, o afinar el tejido endometrial. (23)

Anticonceptivos Orales Combinados

Los anticonceptivos orales combinados, están compuestos por dos hormonas (estrógeno y progesterona) las cuales imitan a las hormonas ováricas; ya que, una vez ingeridos van a inhibir la liberación de las hormonas hipofisarias que estimulan la ovulación; asimismo, estos anticonceptivos orales combinados afectan al revestimiento de la capa endometrial y hacen que el moco cervical se espesa, evitando así, el pase de los espermatozoides. (24)

Anticonceptivos Orales solo de progestágeno

Los progestágenos orales están indicados en mujeres que cuentan con contraindicaciones para el uso de estrógenos; no obstante, presentan un índice mayor de embarazos en relación con los anticonceptivos orales combinados. Su principal mecanismo de acción es producir también una retroalimentación

negativa al hipotálamo, inhibiendo que se secreta la hormona estimulante de la liberación de gonadotropinas, de modo que no se lleva a cabo la ovulación, el endometrio también se adelgaza y el moco cervical se espesa, inhibiendo del pase de los espermatozoides. (25)

Inyectable combinado

Son fármacos administrados una vez al mes a la usuaria cuyo perfil es similar al de los anticonceptivos orales combinados, los anticonceptivos inyectables combinados contienen una progestina y un estrógeno natural (estradiol), lo cual determina un mejor perfil metabólico. Asimismo, su principal mecanismo de acción es simular las hormonas ováricas, inhibiendo la liberación de las hormonas hipofisarias que propician la ovulación. (26)

Inyectables de progestágenos

Los anticonceptivos inyectables de progestágeno, también conocido con Acetato de Medroxiprogesterona es muy similar a la hormona femenina progesterona, dicho anticonceptivo se utiliza para prevenir embarazos, y esta funciona durante 90 días. Siendo su principal mecanismo de acción, evitar la ovulación, adelgazar la capa endometrial del útero y espesar el moco cervical. (27)

Implante solo de progestina

Es una varilla de plástico, blanda y flexible no biodegradable, que se inserta por debajo de la piel en la parte superior interna del brazo, anticonceptivo altamente eficaz, debido a que, tiene una alta tasa de efectividad del 99,5%, su acción prolongada es por tres o cinco años dependiendo del implante, el principio activo liberado por el torrente sanguíneo es etonogestrel, el cual, impide la ovulación y produce cambios en el moco cervical que dificulta la entrada de los espermatozoides. (28)

Criterios Médicos de elegibilidad para el uso de métodos anticonceptivos

Los criterios médicos de elegibilidad para el uso de métodos anticonceptivos forman parte de un documento que elaboró la Organización Mundial de Salud, como parte de una recomendación acerca de la seguridad de los métodos

anticonceptivos respecto a su uso en base a un contexto en donde existen condiciones médicas y características específicas. (29)

Categorías

La OMS ha conservado el mismo sistema de clasificación desde su primera edición de los Criterios médicos de elegibilidad, para determinar la seguridad de cada método anticonceptivos en relación a alguna condición o consideración médica, la OMS utiliza una escala de cuatro categorías numéricas; tales como, la categoría médica 1 para la cual no existen restricciones al uso del método anticonceptivo, la categoría médica 2, en la cual las ventajas de utilizar el método anticonceptivo generalmente supera los riesgos teóricos o demostrados; es decir, por lo general se puede usar el método anticonceptivo. No obstante, la categoría médica 3, es aquella categoría en la cual los riesgos teóricos o demostrados superan las ventajas de utilizar el método anticonceptivo, por lo tanto, el uso del método no se recomienda, y por último, la categoría médica 4, donde el uso del método anticonceptivo constituye un riesgo inaceptable para la salud, y bajo ningún motivo se deberá utilizar el método anticonceptivo. (30)

Condiciones que contraindican el uso de métodos anticonceptivos hormonales

Existen ciertas condiciones que algunas mujeres pueden presentar, las cuales, podrían contraindicar que estas usen algún método anticonceptivo hormonal; porque, podrían mermar en su salud. Asimismo, dentro de estas condiciones, diferentes estudios, han determinado que tienen relación con la edad de la mujer, si esta tiene o no hábitos de consumir tabaco, si tiene algún riesgo de presentar o es diagnosticada con diabetes, dislipidemias, hipertensión arterial, obesidad, migraña, algún tipo de enfermedad cardiovascular o hepática, algún tipo de cáncer ginecológico, alguna condición de lupus eritematoso. Además, si existe algún riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, o si la mujer cuenta con una infección clínica por virus de inmunodeficiencia adquirida en diferentes estadios, por la interacción del tratamiento, asimismo con las

mujeres que por alguna condición toman medicamentos barbitúricos. Por último, en caso de brindar una anticoncepción posparto, se debe considerar también cuantas semanas / meses posparto tiene esta mujer y si se encuentra brindando lactancia materna o no. (30)

Contraindicaciones para el uso de anticonceptivos hormonales combinados

En el caso de los anticonceptivos hormonales combinados, se considera que mujeres menores de 40 años pueden usarlos sin restricciones (se considera como categoría 1), mujeres mayores o iguales a 40 años, en general podrían usar los métodos hormonales combinados (categoría 2). Mujeres mayores o iguales de 35 años que fume menos de 15 cigarrillos al día en general los riesgos del uso de anticonceptivo combinado superan los beneficios (se consideran dentro de la categoría 3), asimismo, aquellas mujeres mayores o iguales de 35 años que fumen más de 15 cigarrillos diarios tienen contraindicado el uso de anticonceptivos combinados (categoría 4). En relación a si una mujer presenta como condición médica diabetes, se considera de bajo riesgo a mujeres con antecedentes de diabetes gestacional solamente (categoría 1) , en el caso de las mujeres diagnosticadas como diabéticas no insulino dependiente o insulino dependiente, por lo general los beneficios del uso de anticonceptivos combinados es mayor a los riesgos (categoría 2), sin embargo mujeres con nefropatías/ retinopatía / neuropatía o que cuenten con otra enfermedad de diabetes de más de 20 años de duración, se encuentran absolutamente contraindicadas de usar anticonceptivos combinados (categoría 3 y 4). En el caso de las dislipidemias, los riesgos no superan los beneficios del uso de anticoncepción combinada (categoría 2), para las mujeres que padecen de hipertensión arterial tanto para casos que se encuentren controlados o con niveles altos de presión arterial, así como vasculopatías, se encuentra contraindicado el uso de anticonceptivos combinados (categoría 3 y 4)

Para las mujeres con condición de obesidad los beneficios de la anticoncepción superan los riesgos; por lo tanto, no existe restricción para el uso de anticonceptivo combinado (categoría 1 y 2), en el caso de mujeres con condición de migraña con aura a cualquier edad no se recomienda el uso de

esta metodología anticonceptiva (categoría 4). Para cualquier tipo de enfermedad vascular no se recomienda el uso de anticoncepción combinada (categoría 3 y 4); asimismo, con las enfermedades hepáticas, en el caso de hepatitis viral aguda existe más riesgo que beneficio (categoría 3 y 4) para el uso de anticonceptivo combinado; asimismo, la condición de neoplasia hepática maligna está contraindicado el uso de anticoncepción hormonal combinada (categoría 4); no obstante, para los que son portadores o crónicos de hepatitis viral, los beneficios superan los riesgos (categoría 1) para el uso de anticoncepción combinada. En relación, a los cánceres ginecológicos, tanto para el cáncer de cuello uterino (en espera de tratamiento), cáncer de ovario, cáncer endometrial, los beneficios superan los riesgos (categoría 2 y 1); sin embargo, en el caso de pacientes con cáncer de mama con diagnóstico actual está contraindicado el uso de anticoncepción combinada (categoría 4), sobre el lupus eritematoso se encuentra contraindicado el uso de anticonceptivo combinada (categoría 4).

Con respecto a las infecciones de transmisión sexual; tales como, cervicitis por gonorrea o clamidia, otras infecciones (excepto VIH y hepatitis), vaginitis, no existe ningún riesgo; por lo contrario, los beneficios son mayores, para el uso de anticoncepción combinada (categoría 1). No obstante, es diferente con los casos en la que la mujer cuenta con una condición de haber contraído el virus de inmunodeficiencia adquirida, debido a que el tratamiento puede resultar contraproducente con la anticoncepción combinada, en el caso de que la terapia antirretroviral sea con ritonavir, los riesgos superan los beneficios (categoría 3); por lo tanto, no se recomienda el uso de anticoncepción combinada. Asimismo, las mujeres que por alguna condición en la cual presentan convulsiones y toman medicamentos barbitúricos como tratamiento, también se evidencia que los riesgos superan los beneficios (categoría 3).

Por último, en el caso de las mujeres que desean anticoncepción hormonal combinada posparto menor a los 21 días, está contraindicado el uso de anticoncepción combinada (categoría 4); pero, en el caso de que sea mayor a los 42 días, se verifica que los beneficios superan los riesgos (categoría 1) por ello, se considera apto el uso de anticoncepción combinada. Asimismo, cuando la mujer se encuentra dando de lactar a menos de 1 mes de postparto, no se

recomienda el uso de anticoncepción combinada (categoría 3) posterior al primer mes o más, si se podría usar ello (categoría 2).

Contraindicaciones para el uso de anticonceptivos hormonales solo de progestágeno.

En el caso de anticoncepción hormonales sólo de progestágeno, en cuanto a la edad de la mujer tanto para mujeres menores y mayores a 45 años, no hay evidencia científica que indique que exista riesgos para el uso de anticoncepción hormonal sólo de progestágenos (categoría 1 y 2), asimismo para las mujeres con antecedentes de tabaquismo mayores a 35 años que consuman menos de 15 cigarrillos al día o mujeres mayores a 35 años que consuman más de 15 cigarrillos al día, en ambas, no existe contraindicación para el uso de anticoncepción hormonal sólo de progestágeno (categoría 1). En el caso de mujeres con diagnóstico de diabetes, para aquellas que solo tiene antecedentes de diabetes gestacional, no existe contraindicación para el uso de estos anticonceptivos (categoría 1); asimismo, en el caso de diabetes insulínica o no insulínica, los beneficios en general superan los riesgos en el uso del inyectable e implante (categoría 2); pero, en cuanto a nefropatías, retinopatías, neuropatía, u otra enfermedad vascular o diabetes mayores a 20 años de duración, cuentan con una categoría 3; para el uso de inyectable de progestágeno; es decir, que los riesgos son mayores a los beneficios; por lo tanto no se recomienda su uso, no obstante en el caso del implante continúa manteniendo la categoría 2, en la cual los beneficios por lo general superan los riesgos. Asimismo, las dislipidemias, cuentan con una categoría 2; es decir, que los beneficios por lo general también superan los riesgos.

Las mujeres con condición de hipertensión arterial pueden usar la anticoncepción hormonal sólo de progestágeno debido a que la evidencia demuestra que los beneficios en general superan los riesgos (categoría 1 y 2), con excepción de aquellas que desarrollan vasculopatía para las cuales los inyectables de progestágeno no se recomiendan por los riesgos que puede representar para su salud (categoría 3).

Las mujeres con obesidad no tienen contraindicación alguna para usar métodos de anticoncepción hormonal sólo de progestágenos (categoría 1). Sobre la condición de mujeres con migraña, se recomienda que aquellas que presentan migraña con aura a cualquier edad no utilicen ni inyectables ni implantes, debido a que estos cuentan con una categoría 3. Para cualquier tipo de enfermedad vascular los beneficios del uso de anticonceptivos hormonal solo de progestágenos por lo general superan los riesgos (categoría 2). No obstante, con las neoplasias hepáticas malignas, no se recomienda el uso de progestágenos (categoría 3), a diferencia de la hepatitis viral aguda o crónica para ambas si está permitido el uso de progestágenos (categoría 1).

Asimismo, en las mujeres con cánceres ginecológicos como cáncer de cuello uterino, ovárico, o endometrial el uso de progestágenos no se encuentra contraindicado (categoría 1 y 2), no obstante, con el cáncer de mama, no se debe usar los métodos; ya que, se encuentra contraindicado (categoría 4). En cuanto a la condición de lupus eritematoso no se recomienda el uso de inyectable ni implante; ya que ambos presentan riesgos para la salud de la mujer con esta condición médica (categoría 3).

Respecto, a las mujeres con infecciones de transmisión sexual de cervicitis por clamidia o gonorrea, vaginitis, u otra infección de transmisión sexual no existen ninguna contraindicación para el uso de progestágenos (categoría 1). De igual manera con las mujeres cuya condición es ser VIH positivo pueden usar con seguridad dichos métodos debido a que su condición y su esquema de tratamiento, no generan problema con la anticoncepción hormonal solo de progestágenos (categoría 1). En el caso del uso de barbitúricos tampoco se evidencia riesgo en el uso de anticoncepción hormonal de progestágenos (categoría 1).

Por último, para las mujeres que buscan anticoncepción posparto, o que se encuentran dando de lactar, el uso de la anticoncepción hormonal sólo de progestágenos no cuenta con ninguna contraindicación para su uso (categoría 1).

Rol del Obstetra en la Planificación familiar

Los servicios de planificación familiar son entregados por el personal de salud que se encuentre capacitado para brindarles, dentro de ellos se encuentra el personal obstetra. El cual debe comprender que dicho servicio se le debe brindar a toda persona que desee espaciar o postergar su fecundidad, además, se le debe brindar orientación y apoyo educativo para contribuir a esclarecer cualquier duda que pudiera tener de algún método anticonceptivo en particular; asimismo, se debe poner énfasis entre las características que presenta cada método anticonceptivo y los deseos de cada usuaria o la pareja. (32)

Funciones del Obstetra en la atención de planificación familiar de acuerdo con la norma técnica de Planificación familiar.

El personal obstetra debe realizar la evaluación clínica de la / el usuario/o, llevando a cabo una evaluación integral de las usuarias, realizando anamnesis y examen físico. Luego de ello el personal debe identificar los métodos anticonceptivos más apropiados para cada usuaria, pudiendo ser estas de manera temporal o definitiva. Después de identificar esto, el / la obstetra determina las posibles opciones anticonceptivas cuidando que estas no afecten la salud de la usuaria; es decir, aplicando los criterios médicos de elegibilidad. En consecuencia, se debe proveer a la usuaria del método anticonceptivo que ha elegido, y registrar esto en la historia clínica y otros formularios que sean parte del sistema de información. Por último, se debe realizar un seguimiento o control evaluando la conformidad del método, el estado de salud de la usuaria, que se esté usando correctamente este, y si hay la presencia de algún efecto secundario. (32)

2.1.3. Definición de términos

Contraindicación: Estado o condición, especialmente de naturaleza patológica, que hace inadecuado o peligroso utilizar un determinado tratamiento farmacológico.

Anticonceptivo: Medio que impide la fecundación del óvulo por el espermatozoide.

Planificación Familiar: Conjunto de prácticas orientadas de manera general al control de la reproducción sexual mediante el uso de métodos anticonceptivos, que se usan en la práctica del acto sexual.

Progestágeno: Sustancia hormonal o equivalente que favorece el curso normal de la gestación. Pero en dosis elevadas llega a impedir la ovulación, por lo que se emplea como componente de los anticonceptivos.

Estrógeno: Compuesto esteroideo femenino. Se produce en el ovario, cuya función es la aparición y mantenimiento de los caracteres sexuales femeninos.

2.2. Formulación de hipótesis

No requiere hipótesis, por ser un estudio descriptivo.

CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Diseño metodológico

3.1.1. Tipo de estudio

Descriptivo transversal

3.1.2. Diseño

Observacional

3.2. Población

Serán las 660 mujeres usuarias de métodos anticonceptivos hormonales en el servicio de Planificación Familiar del Centro de Salud “10 de octubre” atendidas de enero a junio del año 2023.

3.3. Muestra

La muestra será calculada a través del aplicativo Openepi, a un nivel de confianza del 95%, con una proporción del 50% y una precisión de 0.05, por lo cual se determinó que la muestra estará conformada por 244 mujeres usuarias de métodos anticonceptivos hormonales atendidas en el servicio de Planificación Familiar del Centro de Salud “10 de octubre” en dicho semestre.

Criterios de inclusión:

- Historias clínicas de mujeres que usen métodos anticonceptivos hormonales.
- Historias clínicas que cuenten con los datos completos.

Criterios de exclusión:

- Historias clínicas de mujeres que usen métodos anticonceptivos hormonales menores de 18 años.
- Historias clínicas de mujeres usuarias de DIU hormonal.
- Historias clínicas de mujeres usuarias del parche hormonal.
- Historias clínicas de mujeres usuarias de anillo vaginal.

Tipo de muestreo

- No probabilístico, por conveniencia.

3.4. Variables

Variable de estudio 1:

Contraindicaciones médicas de anticonceptivos hormonales.

Definición conceptual: Condiciones médicas que puedan presentar las mujeres; que, ponen en riesgo su salud; ya que, presentan cierta incompatibilidad con los principios activos de los métodos anticonceptivos hormonales, provocando que estas condiciones médicas se agraven.

Definición operacional: Son las condiciones médicas que contraindican el uso de los métodos anticonceptivos hormonales, que presentan las mujeres usuarias del Centro de Salud “10 de Octubre”, que serán medidas a través del cuestionario como instrumento, donde se obtendrán, los porcentajes de cuántas de estas usuarias de métodos anticonceptivos presentan contraindicaciones para el uso de estos.

3.5. Operacionalización de variables

Variable	Dimensiones	Indicadores	Valor final	Tipo	Escala
Contraindicaciones médicas de los anticonceptivos hormonales	Contraindicaciones médicas de los anticonceptivos hormonales combinados	Presencia de tabaquismo.	Sí No	Cualitativo	Nominal
		Antecedente médico de Diabetes Mellitus con complicaciones (nefropatías / neuropatías / retinopatías)	Sí No	Cualitativo	Nominal
		Antecedentes médicos de Hipertensión Arterial o presiones arteriales mayores a 160 mmHg sistólica y mayor a 100 mmHg diastólica	Sí No	Cualitativo	Nominal

		Presencia de migraña con aura a cualquier edad	SÍ No	Cualitativo	Nominal
		Antecedentes de Accidente Cerebro Vascular (ACV)	SÍ No	Cualitativo	Nominal
		Enfermedades Vasculares	SÍ No	Cualitativo	Nominal
		Antecedentes de Hepatitis viral aguda	SÍ No	Cualitativo	Nominal
		Antecedentes de Neoplasia Hepática	SÍ No	Cualitativo	Nominal
		Antecedente de Neoplasia Mamaria	SÍ No	Cualitativo	Nominal
		Antecedente de lupus eritematoso	SÍ No	Cualitativo	Nominal
		Presencia de Infección por VIH	SÍ No	Cualitativo	Nominal

		Interacciones con tratamiento antirretroviral	SÍ No	Cualitativo	Nominal
		Antecedente de epilepsia	SÍ No	Cualitativo	Nominal
		Interacciones con tratamiento barbitúricos	SÍ No	Cualitativo	Nominal
		Posparto menor a los 21 días	SÍ No	Cualitativo	Nominal
		Lactancia materna menor a 6 meses	SÍ No	Cualitativo	Nominal
	Contraindicaciones médicas de los anticonceptivos hormonales de progestágeno	Antecedente médico de Diabetes Mellitus con complicaciones (nefropatías / neuropatías / retinopatías)	SÍ No	Cualitativo	Nominal
		Presencia de vasculopatías	SÍ No	Cualitativo	Nominal

		Presencia de migraña con aura a cualquier edad	Sí No	Cualitativo	Nominal
		Antecedentes de Neoplasia Hepática	Sí No	Cualitativo	Nominal
		Antecedente de Neoplasia Mamaria	Sí No	Cualitativo	Nominal
		Antecedente de Lupus Eritematoso	Sí No	Cualitativo	Nominal
		Presencia de sangrados irregulares	Sí No	Cualitativo	Nominal

3.6. Técnica

El presente estudio aplicará la técnica observacional en base a la aplicación de una ficha de recolección de datos que se llenará de acuerdo con la información registrada en las historias clínicas de las mujeres usuarias de métodos anticonceptivos hormonales de dicho Centro de Salud.

3.7. Instrumento de recolección de datos

El instrumento que se usará en el presente estudio será la ficha de recolección de datos, la cuál será creado por la investigadora y contará con 25 ítems. Dichos ítems serán divididos en dos dimensiones; la primera, será para determinar las contraindicaciones en el uso de los anticonceptivos hormonales combinados (17 ítems); y la segunda dimensión, será para determinar las complicaciones del uso de los anticonceptivos hormonales solo de progestágeno; los cuales son los inyectables e implantes (8 ítems). Asimismo, dicho instrumento tendrá que ser valorado por juicio de expertos, para lo cual se le solicitará su apoyo a cuatro expertos en la materia para que puedan evaluar la pertinencia, relevancia y claridad de los ítems.

3.8. Procedimientos

En primer lugar, el presente trabajo deberá ser aprobado por la asesora, para luego ser presentado ante el Comité de Investigación de la Escuela Profesional de Obstetricia, para poder obtener la resolución. Posterior a ello, se deberá presentar el proyecto al Comité de Ética de la Facultad de Medicina de San Fernando, con la finalidad de poder solicitar el permiso al Centro de Salud 10 de octubre, para poder realizar nuestra investigación ahí; anexando dicho informe emitido por el Comité de Ética. Asimismo, se deberá coordinar con la jefa de Obstetricia y las Obstetras encargadas del servicio de Planificación Familiar. Seguido, se identificará las historias clínicas que cumplan con los criterios de inclusión determinados para este estudio, las cuales serán revisados con la ficha de recolección de datos.

3.9. Análisis de datos

En un principio se realizará una base de datos en Microsoft Excel 2016, luego de ello, dichos datos se procesarán con el paquete estadístico SPSS versión 16. Se realizará un análisis estadístico descriptivo de variables cualitativas las cuales serán medidas mediante frecuencias y porcentajes; asimismo, se realizará también un análisis descriptivo de las variables cuantitativas las cuales serán medidas de tendencia central como promedio y mediana y medidas de dispersión como la desviación estándar o el rango intercuartílico, según corresponda la distribución de los datos. Por último, todos estos resultados serán presentados en tablas.

3.10. Consideraciones éticas

Al ser un estudio de fuente secundaria, no requiere necesariamente que sea evaluado por el Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Medicina de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin embargo, de acuerdo con la declaración de Helsinki, se respetarán los cuatro principios bioéticos; mencionados. Asimismo, los datos mencionados en cada historia clínicas; serán totalmente confidenciales y codificados, impidiendo que se acceda a las identidades de las pacientes.

CAPÍTULO IV: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

3.1. Recursos disponibles

Recursos Humanos
Asesor
Recursos materiales
Laptop Core I3
USB Kingston 8 GB
Mouse inalámbrico

3.2. Cronograma de actividades

N. °	Actividades	Duración en meses y semanas																											
		Julio 2023				Agosto 2023				Setiembre 2023				Octubre 2024				Noviembre 2024				Diciembre 2024				Enero 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Búsqueda sistemática de información	X	X																										
2	Descripción y formulación problema			X																									
3	Justificación y objetivos				X																								
4	Elaboración de marco teórico					X	X	X																					
5	Formulación de hipótesis y metodología								X																				
6	Conformidad del proyecto por parte de la asesora							X																					
7	Aprobación del proyecto por la escuela de Obstetricia									X	X																		
8	Aprobación del comité de ética de la UNMSM															X	X												
9	Validación del instrumento																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

N. °	Actividades	Duración en meses y semanas																											
		Febrero 2024				Marzo 2024				Abril 2024				Mayo 2024				Junio 2024				Julio 2024				Agosto 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
10	Validación del instrumento	X	X	X	X	X	X	X	X																				
11	Solicitud de aprobación de la Dirección Regional de Salud Lima Centro									X	X	X	X																
12	Recolección de la información													X	X	X													
13	Elaboración de matriz de datos																X	X	X										
14	Elaboración de las tablas																		X	X									
15	Interpretación de los datos																				X	X							
16	Discusión de los resultados																					X							
17	Conclusiones y sugerencias																						X						
18	Revisión del informe final de tesis																								X				
19	Sustentación de tesis																									X			

3.3. Presupuesto

Los recursos y servicios empleados para el desarrollo de esta investigación serán autofinanciados por la investigadora.

Recursos humanos

Recursos humanos	Costo en soles ((S/.))
Estadístico	500
Subtotal 1	500

Recursos materiales

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Costo en soles (S/.)
1 millar de hojas bond A4 de 80 gr.	3	10.50	31.5
Lapiceros Pilot	5	15	15
Folder A4	2	10	10
Subtotal 2			56.50

Servicios

Descripción	Costo en soles (S/.)
Internet	99
Luz	210
Telefonía	50
Transporte	60
Subtotal 3	419

Referencias bibliográficas

1. Anticoncepción. 3B Scientific; 2004.
2. Counselling for Maternal and Newborn Health Care: A Handbook for Building Skills. Geneva: World Health Organization; 2013. 12, FAMILY PLANNING COUNSELLING. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK304183/>
3. Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Facultad de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins/Centro para Programas de Comunicación (CCP), Proyecto de Conocimientos sobre la Salud. Planificación familiar: Un manual mundial para proveedores. Baltimore y Washington: CCP y OPS, 2019.
4. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use. 5th edition. Geneva: World Health Organization; 2015. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK321151/>
5. World Health Organization. (2022). World health statistics 2022: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. World Health Organization. Available from: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/356584>.
6. Römer T. Medical eligibility for contraception in women at increased risk. Dtsch Arztebl Int [Internet]. 2019;116(45):764–74. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3238/arztebl.2019.0764>.
7. Teal S, Edelman A. Contraception selection, effectiveness, and adverse effects: A review: A review. JAMA [Internet]. 2021;326(24):2507–18. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1001/jama.2021.21392>.
8. Ponce de Leon RG, Ewerling F, Serruya SJ, Silveira MF, Sanhueza A, Moazzam A, et al. Contraceptive use in Latin America and the Caribbean with a focus on long-acting reversible contraceptives: prevalence and inequalities in 23 countries. Lancet Glob Health [Internet]. 2019;7(2):e227–35. Disponible en: [http://dx.doi.org/10.1016/S2214-109X\(18\)30481-9](http://dx.doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30481-9)
9. Nápoles Méndez D, Couto Núñez D. Riesgo de tromboembolismo venoso en mujeres consumidoras de anticonceptivos hormonales combinados. Medisan [Internet]. 2016 [citado el 24 de mayo de 2023];20(12):2548–57. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192016001200014&lang=es
10. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perú: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2022 [Internet]. 2022. Disponible en:

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1898/libro.pdf

11. Assiri GA, Bannan DF, Alshehri GH, Alshyhani M, Almatr W, Mahmoud MA. The contraindications to combined oral contraceptives among reproductive-aged women in an obstetrics and gynaecology clinic: A single-centre cross-sectional study. *Int J Environ Res Public Health* [Internet]. 2022;19(3):1567. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3390/ijerph19031567>
12. Dutton C, Kim R, Janiak E. Prevalence of contraindications to progestin-only contraceptive pills in a multi-institution patient database. *Contraception* [Internet]. 2021;103(5):367–70. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.contraception.2021.01.010>
13. Judge CP, Zhao X, Sileanu FE, Mor MK, Borrero S. Medical contraindications to estrogen and contraceptive use among women veterans. *Am J Obstet Gynecol* [Internet]. 2018;218(2):234.e1-234.e9. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ajog.2017.10.020>
14. Lauring JR, Lehman EB, Deimling TA, Legro RS, Chuang CH. Combined hormonal contraception use in reproductive-age women with contraindications to estrogen use. *Am J Obstet Gynecol* [Internet]. 2016;215(3):330.e1-7. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ajog.2016.03.047>
15. Corrêa DAS, Felisbino-Mendes MS, Mendes MS, Malta DC, Velasquez-Melendez G. Factors associated with the contraindicated use of oral contraceptives in Brazil. *Rev Saude Publica* [Internet]. 2017;51(0):1. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1590/S1518-8787.2017051006113>
16. White K, Potter JE, Hopkins K, Fernández L, Amastae J, Grossman D. Contraindications to progestin-only oral contraceptive pills among reproductive-aged women. *Contraception* [Internet]. 2012;86(3):199–203. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.contraception.2012.01.008>
17. Grossman D, White K, Hopkins K, Amastae J, Shedlin M, Potter JE. Contraindications to combined oral contraceptives among over-the-counter compared with prescription users. *Obstet Gynecol* [Internet]. 2011;117(3):558–65. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1097/AOG.0b013e31820b0244>
18. Del Toro Rubio M, Ruidíaz Gómez KS, Barrios Puerta Z. Conocimientos y prácticas sobre métodos de planificación familiar en adolescentes escolarizados de Cartagena-Bolívar. *Rev Cienc Cuid* [Internet]. 2018 [citado el 24 de mayo de 2023];15(2):24–37. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7490932>
19. Recomendaciones sobre prácticas seleccionadas para el uso de anticonceptivos, Tercera edición [Internet]. Geneva: World Health Organization;

2018. Resume executive. Available from:
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK583458/>

20. Peralta-Jiménez JA, Urrego-Mendoza ZC. Salud sexual y reproductiva de mujeres afrocolombianas víctimas del conflicto armado en Bojayá, Chocó, Colombia. Estudio de métodos mixtos, 2019. Rev Colomb Obstet Ginecol [Internet]. 2022;73(1):11–27. Disponible en:
<http://dx.doi.org/10.18597/rcog.3763>
21. Un nuevo estudio de la OMS relaciona las altas tasas de embarazos no planificados con las deficiencias de los servicios de planificación familiar [Internet]. Who.int. [citado el 24 de mayo de 2023]. Disponible en:
<https://www.who.int/es/news/item/25-10-2019-high-rates-of-unintended-pregnancies-linked-to-gaps-in-family-planning-services-new-who-study>
22. Investigación RS. Métodos anticonceptivos: una revisión bibliográfica [Internet]. RSI - Revista Sanitaria de Investigación. 2020 [citado el 24 de mayo de 2023]. Disponible en:
<https://revistasanitariadeinvestigacion.com/metodos-anticonceptivos-una-revision-bibliografica/>
23. Flickr S en. ¿Cuáles son los diferentes tipos de anticonceptivos? [Internet]. <https://espanol.nichd.nih.gov/>. [citado el 24 de mayo de 2023]. Disponible en:
<https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/contraception/informacion/tipos>
24. Casey FE. Anticonceptivos orales [Internet]. Manual MSD versión para profesionales. [citado el 24 de mayo de 2023]. Disponible en:
<https://www.msdmanuals.com/es-pe/professional/ginecolog%C3%ADa-y-obstetricia/planificaci%C3%B3n-familiar/anticonceptivos-orales>
25. Cardo Prats E, Baixauli Fernández VJ. Anticonceptivos orales. Offarm [Internet]. 2004 [citado el 24 de mayo de 2023];23(9):81–6. Disponible en:
<https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-anticonceptivos-orales-13067349>
26. Cardo Prats E, Baixauli Fernández VJ. Anticonceptivos orales. Offarm [Internet]. 2004 [citado el 24 de mayo de 2023];23(9):81–6. Disponible en:
<https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-anticonceptivos-orales-13067349>
27. Mother To Baby | Fact Sheets [Internet]. Brentwood (TN): Organization of Teratology Information Specialists (OTIS); 1994-. Acetato de medroxiprogesterona de depósito (Depo Provera®) 2020 May. Available from:
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK582821/>
28. Ocronos R. Implante anticonceptivo: desde las consultas de atención primaria, papel de la matrona. Ocronos - Editorial Científico-Técnica [Internet]. 2022

[citado el 24 de mayo de 2023]; Disponible en:
<https://revistamedica.com/implante-anticonceptivo-papel-matrona/>

29. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use. 5th edition. Geneva: World Health Organization; 2015. Available from:
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK321151/>
30. Galindo C, del Carmen M. Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos. Salud Publica Mex [Internet]. 2016 [citado el 24 de mayo de 2023];58(1):89–91. Disponible en:
<https://www.scielosp.org/article/spm/2016.v58n1/89-91/>
31. Galindo C, del Carmen M. Criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos. Salud Publica Mex [Internet]. 2016 [citado el 24 de mayo de 2023];58(1):89–91. Disponible en:
<https://www.scielosp.org/article/spm/2016.v58n1/89-91/>
32. Norma técnica de salud de planificación familiar / Ministerio de Salud. Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Dirección de Salud Sexual y Reproductiva -- Lima: Ministerio de Salud; 2017. 130 p.; illus. Disponible en: <http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4191.pdf>

Anexo 1 Instrumento (ficha de recolección de datos)

“Ficha de recolección de datos de las contraindicaciones médicas en usuarias de métodos anticonceptivos hormonales”

I. DIMENSIÓN DE CONTRAINDICACIONES EN EL USO DE ANTICONCEPCIÓN HORMONAL COMBINADA.

DATOS GENERALES	
EDAD:	ESTADO CIVIL:
GRADO DE INSTRUCCIÓN:	
MÉTODO ANTICONCEPTIVO DE USO:	
TIEMPO DE USO DEL MAC ACTUAL:	
ANTERIOR MAC:	

Si la respuesta anterior, fue Anticonceptivo Oral Combinado o Inyectable Mensual, marcar si o no en los siguientes enunciados

N°	Preguntas	Cumple		Observaciones / Comentarios
		Sí	No	
1	¿La usuaria presenta hábitos nocivos de tabaquismo?			
2	En el caso de presentar hábitos nocivos de tabaquismo, ¿fuma más de 15 cigarrillos al día?			
3	¿Cuenta con algún antecedente médico de Diabetes Mellitus?			
4	En el caso sea una paciente cuyo diagnostico sea DM, ¿presenta alguna complicación hepática, en su visión, o adormecimiento de extremidades?			

5	¿Cuenta con algún antecedente médico de HTA, o dentro del examen físico presentó PA mayor a 160/100 mmHg?			
6	¿Refiere dentro de la anamnesis, dolores de cabeza constantes, acompañados por destellos de luz, visión borroso u hormigueo en las extremidades?			
7	¿Cuenta con algún antecedente de ACV por cuál haya sido hospitalizada?			
8	¿Refiere dolor en miembros inferiores, presencia de edema o enrojecimiento?			
9	¿Cuenta con antecedente de hepatitis viral aguda?			
10	¿Cuenta con antecedentes de neoplasia maligna hepática?			
11	¿Cuenta con antecedentes de neoplasia maligna mamaria?			
12	¿Cuenta con antecedentes de lupus eritematoso?			
13	¿Es paciente con Virus de Inmunodeficiencia Adquirida que use Ritonavir dentro de esquema de TTO?			
14	¿Refiere haber presentado episodios de convulsiones?			
15	¿Cuenta con antecedente de epilepsia?			
16	¿Ha presentado un parto en los últimos 21 días?			
17	¿Se encuentra en periodo de lactancia?			

II. DIMENSIÓN DE CONTRAINDICACIÓN EN EL USO DE ANTICONCEPTIVOS HORMONALES SOLO DE PROGESTAGENO.

DATOS GENERALES	
EDAD:	ESTADO CIVIL:
GRADO DE INSTRUCCIÓN:	
MÉTODO ANTICONCEPTIVO DE USO:	
TIEMPO DE USO DE MAC ACTUAL:	
ANTERIOR MAC:	

Si la respuesta anterior, fue Inyectable Trimestral o Implante, marcar si o no en los siguientes enunciados

N°	Enunciados	Cumple		Observaciones / Comentarios
		Sí	No	
1	¿Cuenta con algún antecedente médico de Diabetes Mellitus?			
2	En el caso sea una paciente cuyo diagnostico sea DM, ¿presenta alguna complicación hepática, en su visión, o adormecimiento de extremidades?			
3	¿Refiere dentro de la anamnesis, dolores de cabeza constantes, acompañados por destellos de luz, visión borroso u hormigueo en las extremidades?			
4	¿Refiere dolor en miembros inferiores, presencia de edema o enrojecimiento?			

5	¿Cuenta con antecedentes de neoplasia maligna hepática?			
6	¿Cuenta con antecedentes de neoplasia maligna mamaria?			
7	¿Cuenta con antecedentes de lupus eritematoso?			
8	¿Refiere presentar sangrados vaginales abundantes y constantes sin causa aparente?			